

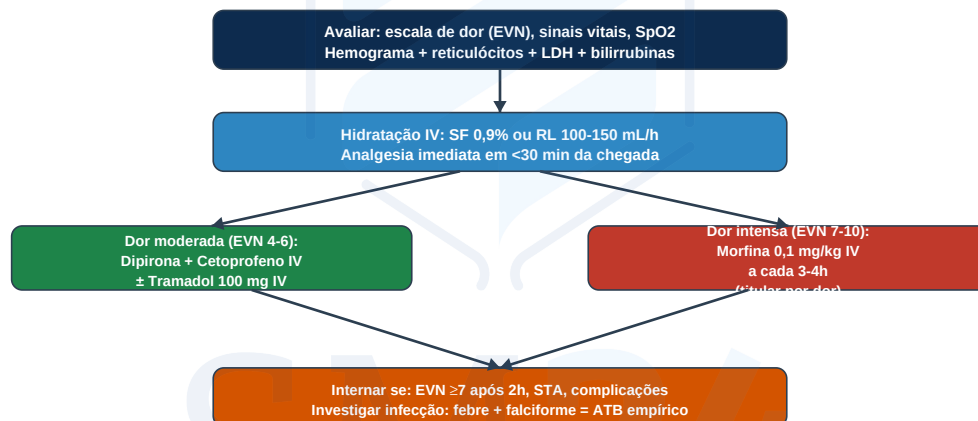
FALCIFORME — HIDRATAR + ANALGESIA + COMPLICAÇÕES

TIPOS DE CRISE — RECONHECER E TRATAR

Tipo de crise	Clínica	Conduta
Vaso-oclusiva (+ comum)	Dor intensa em ossos, articulações, tórax; sem anemia aguda	Hidratação + analgesia escalonada
Síndrome torácica aguda (STA)	Febre + dor torácica + infiltrado pulmonar + hipóxia	Internação, O2, ATB, transfusão de troca se grave
AVC isquêmico	Déficit neurológico focal em criança/jovem	Transfusão de troca (reduzir HbS para <30%) URGENTE
Sequestro esplênico	Criança: esplenomegalia aguda + queda brusca de Hb	Transfusão imediata + esplenectomia eletiva posterior
Crise aplásica	Anemia grave + reticulócitos <1% (infecção por Parvovírus B19)	Transfusão se sintomático; imunoglobulina se imunossuprimido
Priapismo	Ereção dolorosa >4h	Hidratação + analgesia + consulta urologia; transfusão se refratário

MANEJO DA CRISE VASO-OCCLUSIVA

CRISE DE DOR — ESCALONAMENTO ANALGÉSICO



SÍNDROME TORÁCICA AGUDA — EMERGÊNCIA

STA = CRISE POTENCIALMENTE FATAL

- Definição: novo infiltrado pulmonar + febre OU sintoma respiratório em paciente falciforme
- Causa: infecção (pneumonia, Mycoplasma) + infarto pulmonar por falcização
- SpO2 <95%: O2 suplementar + considerar VNI se <90%
- ATB: ceftriaxona 2g IV + azitromicina 500mg (cobertura atípicos)
- Transfusão simples (Hb <8) OU transfusão de troca (hipóxia refratária, deterioração)
- Broncodilatador: beta-2 agonista se broncoespasmo
- Não usar O2 profilaticamente se SpO2 >95% — risco de atelectasia

TRANSFUSÃO NA FALCIFORME — QUANDO E COMO

Modalidade	Indicação	Meta
Transfusão simples	Anemia sintomática, STA leve-moderada, pré-operatório	Hb 9-10 g/dL (não mais — risco de hiperviscosidade)
Transfusão de troca	AVC, STA grave, priapismo refratário, pré-op de cirurgia maior	HbS <30% (< 50% como meta mínima aceitável)
Programa de transfusão crônica	Prevenção de AVC (duplex TCD velocidade >200 cm/s), pós-AVC	HbS <30% mensalmente
Hidroxiureia	Profilaxia de crises: ↑HbF, ↓falcização — iniciar após 9 meses de vida	Leucócitos 2.500-4.000 = dose ideal

PREVENÇÃO E CUIDADOS CRÔNICOS

Profilaxias Obrigatórias

- Penicilina V oral: 125 mg 12/12h (até 3 anos) → 250 mg 12/12h (3-5 anos) → até esplenectomia funcional
- Vacinas: Pneumococo (conjugada + polissacarídea), Meningococo, H. influenzae, influenza anual, Hepatite B
- Ácido fólico: 5 mg/dia (eritropoese acelerada)
- Triagem neonatal: teste do pezinho confirmar HbSS ou HbSC

Indicadores para Hidroxiureia

- >3 crises graves/ano que requeiram hospitalização
- STA recorrente
- Anemia grave sintomática (Hb <7 cronicamente)
- Priapismo recorrente
- Vasculopatia cerebral sem indicação de transfusão crônica
- Dose: 15-35 mg/kg/dia; monitorar hemograma quinzenalmente no início

FEBRE NO PACIENTE FALCIFORME

ATENÇÃO — INFECÇÃO PODE SER FULMINANTE

- ☐ Falciforme + febre = emergência até prova em contrário (asplenia funcional)
- ☐ Hemoculturas + hemograma imediato antes de qualquer antibiótico
- ☐ ATB empírico imediato: ceftriaxona 50-100 mg/kg/d (máx 4g) — cobrir S. pneumoniae
- ☐ Adicionar vancomicina se toxemia, foco de SNC ou resistência local
- ☐ Sépsis fulminante pneumocócica: mortalidade alta — não aguardar resultado de cultura
- ☐ Crise aplásica por Parvovírus B19: Hb cai + reticulócitos <1% → transfundir se sintomático

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 8 anos com anemia falciforme, febre 39°C, dor torácica e SpO2 93% em ar ambiente. Raio-X: infiltrado bibasal novo. Qual diagnóstico e conduta?

- A) Pneumonia bacteriana simples — amoxicilina oral e alta
- B) Síndrome torácica aguda — internar, O2, ceftriaxona + azitromicina, transfusão se deterioração
- C) Asma grave — broncodilatador e corticoide
- D) Derrame pleural — toracocentese diagnóstica
- E) Crise vaso-oclusiva simples — hidratação e morfina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Adolescente falciforme com hemiplegia direita de início súbito. Qual é a conduta mais urgente?

- A) Trombólise com rt-PA IV
- B) Transfusão de troca para reduzir HbS abaixo de 30%
- C) Hidratação e analgesia como na crise vaso-oclusiva
- D) Anticoagulação plena com heparina
- E) TC de crânio e aguardar resultado antes de qualquer intervenção

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Criança de 2 anos com anemia falciforme apresenta Hb 4 g/dL (basal = 8 g/dL) e baço 8 cm palpável. Qual diagnóstico e conduta?

- A) Crise aplásica por Parvovírus — imunoglobulina IV
- B) Sequestro esplênico — transfusão imediata de hemácias
- C) Síndrome hemolítica — hidratação e espera
- D) Infecção bacteriana grave — antibiótico IV
- E) Hemólise por G6PD — suspender medicamentos oxidantes

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o objetivo da hidroxiureia na anemia falciforme?

- A) Substituir as hemácias falciformes por hemácias normais
- B) Aumentar a hemoglobina fetal (HbF), que não falciza, reduzindo crises
- C) Reduzir a viscosidade sanguínea por diluição
- D) Eliminar a infecção pelo Parvovírus B19
- E) Prevenir a formação de anticorpos antieritrocitários

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que pacientes com anemia falciforme têm asplenia funcional e alto risco de sepse fulminante?

- A) Por esplenectomia cirúrgica realizada na infância
- B) Porque os infartos esplênicos repetidos levam à fibrose e perda da função (autoesplenectomia)
- C) Porque a anemia reduz a chegada de leucócitos ao baço
- D) Porque a eritropoese compensatória desaloja os linfócitos esplênicos
- E) Porque a hidroxiureia suprime a imunidade esplênica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Síndrome Torácica Aguda (STA): novo infiltrado + febre ou sintoma respiratório em falciforme. SpO2 93% = hipóxia. Conduta: O2, ceftriaxona + azitromicina (cobre bacteriano e atípico), broncodilatador se broncoespasmo, transfusão simples se Hb <8 ou de troca se deterioração rápida.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

AVC em falciforme: transfusão de troca (exsanguineotransfusão) urgente para reduzir HbS <30%. Trombólise é contraindicada (risco de hemorragia em paciente com anemia e coagulopatia). Programa de transfusão crônica para prevenção secundária.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sequestro esplênico: queda abrupta da Hb + esplenomegalia aguda (baço retém hemácias falciformes). Em criança <5 anos com basal 8 → Hb 4 = emergência. Transfusão imediata. Risco de recorrência → esplenectomia eletiva após recuperação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hidroxiureia aumenta HbF (hemoglobina fetal) que não polimeriza e não causa falcização. Mecanismo: ativa gene HBG1/2 via produção de NO. Reduz crises em 50%, hospitalizações e mortalidade. Monitorar leucopenia (toxicidade).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Autoesplenectomia: infartos esplênicos repetidos por falcização → fibrose progressiva → baço não funcional aos 5 anos na maioria dos HbSS. Sem baço, sem opsonização de *S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *H. influenzae* → sepse fulminante. Profilaxia: penicilina + vacinação.

SM24
Suporte ao Plantão Médico